

MEMO DECYZYJNE v3.11 — DOKUMENT-CENTRUM PAKIETU OBYWATELSKIEGO UD207

Wersja pakietu: v1.10 (16 maja 2026 r., po fazach A, A2, A3, B, C, integracji paradoksu salinomycyny) **Wersja MEMO:** 3.11 (aktualizacja v3.10 z 15.05.2026 — uwzględnia zmiany) **Koordynacja:** zespół obywatelski pakietu UD207 **Cel dokumentu:** mapa pakietu z systemem odsyłaczy + glosariusz pojęć + skonsolidowana bibliografia.

I. CO TO JEST DOKUMENT-CENTRUM

MEMO_DECYZYJNE v3.11 jest **mapą architektoniczną pakietu obywatelskiego UD207**. Spina 22 deliverables (dokumenty publiczne, wewnętrzne, materiały dla Magdy, materiały operacyjno-strategiczne) w jedną sieć odniesień. Stosuje **sześć mechanizmów integracji** zaprojektowanych w Architektura_Integracji_Pakietu_UD207.docx:

1. System odsyłaczy między dokumentami (każdy dokument ma sekcję „Powiązane dokumenty pakietu”)
 2. Wspólna numeracja paragrafów konstytucyjnych (§1–§13 z Sekcji v3.0)
 3. Wspólny glosariusz pojęć (sekcja IV poniżej)
 4. Skonsolidowana bibliografia pakietu (sekcja V poniżej)
 5. Spójna wersjonalizacja (v1.10)
 6. Spójne nagłówki/stopki (do wdrożenia w finalnej dystrybucji)
-

II. MAPA PAKIETU — 22 DELIVERABLES, 5 WARSTW

Warstwa 1 — TRZON DOWODOWY (kwiecień 2026, baza pakietu)

Dokument	Wersja	Funkcja	Adresat	Odsyła do
Dokument_A_Stanowisko_v3.9.docx	v3.9	Główny dokument stanowiska — analiza spójności EBM w polskiej onkologii	MZ, NIL, AOTMiT, RPP, Komisja Zdrowia	Zał. 1 v1.10, Zał. 2 v1.4, Wytyczne
Zalacznik_1_Policy_Paper_EBM_v1.10.docx	v1.10	Policy Paper EBM + Część B = Sekcja Konstytucyjna v3.0	jw. + prawnicy, dziennikarze	Dokument A, Memorandum 2.0
Zalacznik_2_M	v1.4	Model	jw.	Wytyczne,

odel_Toru_2_v1.4.docx		funkcjonowania ambulatoryjnych ośrodków terapii wspomagających		Dokument A \$6.6
Wytyczne_Salinomycyna_v1.1.docx	v1.1	Szczegółowe wytyczne kliniczne i regulacyjne dla salinomycyny	NIL, AOTMiT, środowisko medyczne	Zał. 2 sekcja 11, Dokument A \$6.6.5

Warstwa 2 — TRZON PRAWNY (16 maja 2026 wieczór)

Dokument	Wersja	Funkcja	Adresat	Odsyła do
Sekcja_Konstytucyjna_v3.0_d_o_Zalacznik_1_v1.10.docx	v3.0	13 paragrafów konstytucyjnych — synteza Magdy + empiryka + Perplexity	wszyscy odbiorcy pakietu	Wszystkie dokumenty operacyjne
Memorandum_prawne_UD207_v2.0.docx	v2.0	Skondensowane 10 stron prawne A/B/C/D dla BAS/kancelarii /posłów	BAS, kancelarie, prawnicy konstytucjonali ści	Sekcja v3.0, Załącznik 1
Analiza_UD207_v2.0_po_korektach_DO_AKCEPTACJI.docx	v2.0	Pełna 16-stronicowa analiza autorstwa M. (do akceptacji po korektach)	M.; po decyzji — pakiet	Sekcja v3.0, Memorandum 2.0
Analiza_UD207_Magda_z_po_prawkami.docx	v1 (z czerwoną edycją)	Analiza M. + 19 propozycji inline	M. (do dyskusji)	Komentarz dla Magdy, Sekcja v3.0

Warstwa 3 — DOKUMENTY OPERACYJNE / DYSTRYBUCYJNE (Obieg A)

Dokument	Wersja	Funkcja	Adresat	Odsyła do
Apel_do_Prezydenta_Nawrockiego_v1.docx	v1 (warunkowy)	Apel art. 122 ust. 3 — wersja warunkowa do aktywacji	Prezydent RP (po Sejmie/Senacie)	Sekcja v3.0, Memorandum 2.0
Apel_do_Prezydenta_v2	v2	Aktywowana	jw.	jw.

denta_Nawrociego_v2_ACTIVATED.docx		wersja Apelu — gotowa do wysłania po uchwaleniu		
Brief_Medialny_Lex_Szarlatan.docx	v1	7 propozycji artykułów dla dziennikarzy	media (Rzeczpospolita, OKO.press, GW Magazyn, Polityka, Onet)	Sekcja v3.0
Memo_Ekonomiczne_NFZ_v1.docx	v1	Argument ekonomiczny NFZ + OSR + vacatio legis	dziennikarze ekonomiczni, posłowie	Sekcja v3.0 §1, §13
Memo_Strategia_Rozszerzona_v1.docx	v1 (wewnętrzny)	Strategia 5-warstwowa pakietu	koordynator + zespół	wszystkie deliverables
Petycja_Publiczna_v1.docx	v1	Petycja — 5 postulatów, 12 argumentów	Sejm/Senat + dystrybucja społeczna	Sekcja v3.0 §13 (postulaty)
List_Otwarty_Lekarzy_v1.docx	v1	List otwarty — 6 postulatów, 9 argumentów	NIL, środowisko medyczne, media	Sekcja v3.0
List_Przewodni_Arlukowicz_v1.docx	v1	List do Przewodniczącego Komisji Zdrowia	B. Arłukowicz	wszystkie deliverables prawne

Warstwa 4 — DOKUMENTY WEWNĘTRZNE (Obieg B)

Dokument	Wersja	Funkcja	Adresat	Status
Dossier_Obieg_B_v2.0.docx	v2.0	Dossier wewnętrzne (Rada Ekspertów RPP, dowody pharma-circuit)	adresaci wewnętrzni	Pełna anonimizacja (zaktualizowane 19.05.2026)
List_przewodni_Obieg_B_v2.docx	v2	List przewodni do Obiegu B	jw.	Pełna anonimizacja

Warstwa 5 — MATERIAŁY OPERACYJNO-STRATEGICZNE

Dokument	Wersja	Funkcja
Komentarz_dla_Magdy_dla_Analizy_ÜD207.docx	v2	Pisemny komentarz do M. z

Odpowiedz_dla_Magdy_Is cador_i_Salinomycyna.docx	v1	uwagami merytorycznymi Odpowiedź na 2 wątpliwości M. (16.05.2026 wieczór)
Plan_Integracji_Magdy_d o_Pakietu.docx	v1	Plan operacyjny integracji analizy Magdy
Architektura_Integracji_P akietu_UD207.docx	v1	4 modele integracji + 6 mechanizmów + plan wdrożenia
Zapytania_Perplexity_v13 _weryfikacja_UD207.docx	v13	11 zapytań weryfikacyjnych do Perplexity
MEMO_DECYZYJNE_v3.1 0_aktualizacja_pakietu.docx	v3.10	Poprzednia wersja niniejszego dokumentu
MEMO_DECYZYJNE_v3.1 1_dokument_centrum.docx	v3.11	NINIEJSZY DOKUMENT
SNAPSHOT_STANU_PAK IETU_16052026.md, _v2.md, _v3.md	v1, v2, v3	Snapshoty kontekstu (punkty powrotu)

III. HIERARCHIA DOKUMENTÓW — KTO JEST „GŁÓWNYM”

Po przyjęciu UD207 przez Radę Ministrów (12.05.2026) hierarchia dokumentów pakietu wygląda następująco:

1. **Twarz pakietu — Dokument A Stanowisko v3.9 + Załącznik 1 Policy Paper EBM v1.10** (zawiera Sekcję v3.0 jako Część B). Pełne stanowisko z empiryką EBM i analizą konstytucyjną.
2. **Dokument prawny dla profesjonalistów — Memorandum prawne UD207 v2.0.** Skondensowane 10 stron dla BAS, kancelarii, prawników.
3. **Dokumenty dystrybucyjne dla różnych adresatów** — Apel (Prezydent), Brief (media), Memo Ekonomiczne (ekonomiści/dziennikarze), Petycja (parlament/społeczeństwo), List Otwarty (lekarze), List Arłukowicz (Komisja Zdrowia).
4. **Materiał wewnętrzny — Dossier Obieg B** (anonimizowany, adresowany do kluczowych osób środowiska medycznego).
5. **Materiały operacyjno-strategiczne** — wewnętrzne narzędzia koordynacji.

IV. GLOSARIUSZ POJĘĆ — definicje wiążące dla całego pakietu

Pojęcie	Definicja używana w pakiecie	Źródło / wsparcie
---------	------------------------------	-------------------

**Aktualna wiedza
medyczna**

Stan konsensusu naukowego ustalany ad hoc, **kontekstualny**, wymagający dowodu z opinii biegłych w każdej sprawie; wątpliwości rozstrzygane in dubio pro reo. NIE jest jednoznacznym, predefiniowanym katalogiem.

SN III KK 212/18 (5.06.2019); Sekcja v3.0 §2

**Praktyka
pseudomedyczna**

Wg art. 67zj projektu UD207 — cztery kategorie zachowań: (1) działania zdrowotne osoby niewykonywającej zawodu medycznego; (2) oferowanie/stosowanie metody niebędącej świadczeniem zdrowotnym z przypisaniem właściwości; (3) prowadzące do pogorszenia zdrowia LUB niepodjęcia metody zgodnej z aktualną wiedzą medyczną; (4) wykonywanie działalności leczniczej bez wpisu do rejestru. Plus dezinformacja medyczna z zyskiem i publicznym rozpowszechnianiem.

Wersja 4.0 z 13.05.2026, art. 67zj

Świadczenie zdrowotne

Pojęcie funkcjonujące w ustawie o działalności leczniczej; w pakiecie używane z zastrzeżeniem, że jego stosowanie jako elementu deliktu administracyjnego zagrożonego karą 1 mln zł wymaga rozgraniczenia z działalnością edukacyjną, profilaktyczną, dietetyczną, religijną, coachingową, dziennikarską.

Ustawa o działalności leczniczej

Funkcjonalne odwrócenie ciężaru dowodu	(po korekcie z 16.05.2026) — konstrukcja, w której organ wykazuje wyłącznie subsumpcję pod definicję, a podmiot ponosi ciężar wykazania okoliczności egzoneracyjnych z art. 67zł ust. 3. W pakiecie nazywane „rodzającym poważne ryzyko nierównowagi proceduralnej”, NIE „funkcjonalnym odwróceniem” (zmniejszenie redakcyjne).	Sekcja v3.0 §3
Kryteria Engela	Test trzech kryteriów ETPC (Engel v. Holandia 8.06.1976): (1) kwalifikacja krajowa, (2) charakter normy, (3) surowość sankcji. Spełnienie → kwalifikacja jako „criminal” w autonomicznym rozumieniu EKPC → aktywacja pełnego standardu art. 6 EKPC.	ETPC; Sekcja v3.0 §3
Compassionate use	Indywidualny program rozszerzonego dostępu pacjenta do leku eksperymentalnego (art. 83 rozporządzenia 726/2004 UE).	Prawo UE
Named-patient basis	Indywidualny dostęp pacjenta do substancji bez dopuszczenia rynkowego, na odpowiedzialność lekarza (art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE).	Prawo UE
OCEBM	Oxford Centre for Evidence-Based Medicine — pięciostopniowa skala dowodów klinicznych (1 = najwyższy, 5 = opinia eksperta).	Sekcja v3.0 §2; Dokument A

GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation — międzynarodowy system gradacji jakości dowodów i siły rekomendacji w wytycznych klinicznych.	Sekcja v3.0 §2; Dokument A
Model Tor 2	Adaptacyjna ścieżka regulacyjna dla terapii dojrzałych z monitoringiem biomarkerowym — propozycja autorska pakietu obywatelskiego.	Załącznik 2 v1.4
Klauzula §6.6.5	Szczególna ścieżka legalizacji substancji z wieloletnią udokumentowaną praktyką ambulatoryjną i monitoringiem CTC/CSC.	Dokument A v3.9 §6.6.5
Arbitralność geograficzna	Sytuacja, w której ta sama praktyka terapeutyczna o tej samej podstawie naukowej jest legalna w jednym państwie członkowskim UE i karalna w innym — w pakiecie demonstrowana paradoksem salinomycyny (Niemcy compassionate use vs Polska UD207).	Sekcja v3.0 §12; Memorandum 2.0 A.5

V. SKONSOLIDOWANA BIBLIOGRAFIA PAKIETU UD207 v1.10

Każdy dokument pakietu, gdy cytuje źródło, może odwoływać się do tej bibliografii skrótem [Bibliografia, A.7] itp.

A. Trybunał Konstytucyjny RP

A.1. K 11/94 (26.04.1995) — nullum crimen sine lege certa A.2. K 17/97 (29.04.1998) — ne bis in idem A.3. K 13/01 (7.03.2002) — vacatio legis A.4. K 18/03 (3.11.2004) — sankcje administracyjne represyjne A.5. SK 27/03 (31.01.2005) — model SOKiK, kontrola merytoryczna A.6. P 19/06 (15.01.2007) — przewidywalność konsekwencji A.7. K 22/06 — rygor natychmiastowej wykonalności A.8. P 26/06 (15.04.2008) — test tożsamości czynu A.9. K 14/07 (2009) — vacatio legis dla nowych sankcji A.10. P 29/13 (2014) —

przyzwolita legislacja, *vacatio legis* A.11. K 1/14 (1.07.2014) — kary administracyjne osób kierujących A.12. P 46/13 (12.05.2015) — podwyższony standard *lex certa* A.13. P 32/12 (21.10.2015) — kumulacja sankcji A.14. K 47/14 (14.10.2015) — minimum 6 mc *vacatio legis* A.15. P 124/15 (20.06.2017) — wysokie kary administracyjne = standard karny

B. Europejski Trybunał Praw Człowieka

B.1. Engel v. Holandia (8.06.1976) — kryteria „criminal charge” B.2. Allenet de Ribemont v. Francja (10.02.1995) — domniemanie niewinności B.3. Hertel v. Szwajcaria (25181/94, 25.08.1998) — niekonwencjonalna dyskusja naukowa B.4. Pretty v. UK (2346/02, 29.04.2002) — autonomia decyzji medycznych B.5. Khuzhin v. Rosja (23.10.2008) — publikacja przed prawomocnością B.6. Frankowicz v. Polska (53025/99, 16.12.2008) — KLUCZOWY: kara dyscyplinarna lekarza za krytyczną opinię, naruszenie art. 10 EKPC B.7. Sergey Zolotukhin v. Rosja (Wielka Izba, 10.02.2009) — *ne bis in idem* (*idem factum*) B.8. Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia (302/02, 10.06.2010) — autonomia wyboru leczenia B.9. Braun v. Polska (2014) B.10. Bédat v. Szwajcaria (29.03.2016) — wolność prasy B.11. A i B v. Norwegia (Wielka Izba, 15.11.2016) — postępowania zintegrowane B.12. Brzeziński v. Polska (25.07.2019) B.13. Tête v. Francja (59636/16, 26.03.2020) B.14. Vavříčka v. Czechy (8.04.2021) — granice obowiązkowej interwencji vs swoboda wyboru B.15. Advance Pharma sp. z o.o. v. Polska (2022) — ochrona osób prawnych

C. Trybunał Sprawiedliwości UE

C.1. Ter Voort (C-219/91, 28.10.1992) C.2. HLH Warenvertrieb i Orthica (C-211/03, 9.06.2005) C.3. Komisja v. Niemcy (C-319/05, 15.11.2007) C.4. VTB-VAB (C-261/07) — pełna harmonizacja dyrektywy 2005/29 C.5. Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08) — pełna harmonizacja C.6. Menci (C-524/15, 20.03.2018) — *ne bis in idem*, test ścisłej konieczności C.7. Garlsson Real Estate (C-537/16) — kumulacja sankcji finansowych

D. Polskie sądownictwo krajowe

D.1. SA Warszawa, VI ACa 397/15 (1.04.2016) — NIL vs UOKiK ws. homeopatii D.2. SN, postanowienie z 10.02.2010 r. — autonomia terapeutyczna lekarza (art. 4 ust. o zawodach lekarza) D.3. SN III KK 212/18 (5.06.2019) — „aktualna wiedza medyczna” jako kontekstualna; sprawa z art. 160 § 2 k.k. D.4. WSA V SA/Wa 767/24 (23.10.2024) — borelioza ILADS D.5. WSA V SA/Wa 1472/24 (28.10.2025) D.6. WSA V SA/Wa 2854/23 (29.10.2025) — sprawa podmiotu leczniczego (klinika integracyjna): salinomycyna, witamina C dożylna, kurkumina, bioelektroterapia; kara 245 tys. zł D.7. SN, postanowienie z grudnia 2025 r. — Izba Odpowiedzialności Zawodowej, kasacja w sprawie lekarza opiekującego się pacjentami onkologicznymi w klinice integracyjnej (uchylenie i umorzenie postępowania NSL) D.8. WSA V SA/Wa 2871/25 (27.01.2026, nieprawomocny)

E. Akty prawa UE

E.1. Dyrektywa 2001/83/WE (Prawo farmaceutyczne UE) — art. 5 ust. 1 *named-patient* E.2. Rozporządzenie 726/2004 — art. 83 *compassionate use* E.3. Dyrektywa 2005/29/WE — nieuczciwe praktyki handlowe, pełna harmonizacja; motyw 9, art. 3 ust. 3 — wyjątek dla zdrowia/bezpieczeństwa produktów E.4. Rozporządzenie 2016/679 (RODO) — art. 5, 6,

17, 35 E.5. Rozporządzenie 1924/2006/WE — oświadczenia zdrowotne (suplementy) E.6. Rozporządzenie 2017/745 — wyroby medyczne E.7. Dyrektywa 2019/1937 — ochrona sygnalistów E.8. Rozporządzenie 2022/2065 (DSA) — art. 16-22 notice-and-action E.9. Rozporządzenie 2024/1083 (EMFA) — Europejski Akt o Wolności Mediów E.10. Karta Praw Podstawowych UE — art. 7, 8, 11, 47, 48, 50

F. Konwencje międzynarodowe i akty Rady Europy

F.1. EKPC — art. 6, 8, 9, 10; Protokół 7 art. 4 (ne bis in idem) F.2. Konwencja z Oviedo (1997) — art. 5 świadoma zgoda; status: Polska podpisała 1999, nieratyfikowana F.3. Rezolucja PACE 1206 (1999) — A European approach to non-conventional medicines (regulacja, nie zakaz)

G. Akty prawa krajowego polskiego

G.1. Konstytucja RP — art. 2, 17, 22, 31 ust. 3, 42, 45, 47, 54, 68, 78, 122, 176 G.2. Kodeks karny — art. 286 (oszustwo) G.3. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty — art. 4 (autonomia terapeutyczna), art. 58 ust. 1 (świadczenia bez uprawnień), art. 58 ust. 4 (eksperyment bez zgody) G.4. Kodeks postępowania administracyjnego — art. 7, 10, 81, 108 G.5. Ustawa o działalności leczniczej G.6. Prawo farmaceutyczne — art. 21 (homeopatia uproszczona), art. 37 (off-label) G.7. Ustawa z 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym G.8. Prawo prasowe G.9. Prawo przedsiębiorców (6.03.2018) — art. 8, 11, 12 (proporcjonalność) G.10. Ustawa z 17.08.2023 o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. 2023 poz. 1972) G.11. Ustawa z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów G.12. Regulamin pracy Rady Ministrów — art. 50 ust. 1 (OSR)

H. Publikacje recenzowane

H.1. Makowska M., Mulinari S., Ozieranski P. (2025), *Pharmaceutical Industry Payments to Patient Organizations in Poland*, Int J Soc Determinants Health Health Serv; 55(2):199–212. PMID 39726201, PMC11977834 H.2. Czech M. et al. — Frontiers in Public Health 2024 (PMC10975328) — 15 firm pharma H.3. Czech M. et al. — Frontiers in Public Health 5.12.2025, DOI 10.3389/fpubh.2025.1682169 — MSD funding H.4. Czech M. et al. — Viruses 2025, DOI 10.3390/v18010060 — Sanofi, AstraZeneca H.5. Samoliński B. et al. — ScienceDirect 2025, art. S2213219825005355 — honoraria od „patient ombudsman” (RPP) H.6. Naujokat C., Steinhart R. (2012), *Salinomycin as a drug for targeting human cancer stem cells*, J Biomed Biotechnol 2012;2012:950658, DOI 10.1155/2012/950658 H.7. Salcher-Konrad M., Naci H., Davis C. (2023), BMJ Global Health 8(9):e012899 H.8. Naci H. et al. (2024), Lancet Oncology 25(6):760–769, PMID 38754451 H.9. Horst A. et al. (2026), Quality of Life Research 35(3):72, PMID 41677984 H.10. Cherny N.I. et al. (2025), ESMO-MCBS v2.0, Annals of Oncology 36(8):866–908, PMID 40409995

I. Dokumenty rządowe i stanowiska publiczne

I.1. KPRM, karta projektu UD207 wersja 4.0 z 13.05.2026 (legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12398957) I.2. Komunikat MZ z 17.06.2025 — gov.pl/web/zdrowie I.3. Sprawozdania roczne RPP 2019–2024 (BIP RPP) I.4. Skład Rady Ekspertów RPP — gov.pl/web/rpp/rada-ekspertow-2 I.5. **Stanowisko 7 organizacji**

pracodawców systemu ochrony zdrowia (Pracodawcy dla Zdrowia, Lewiatan, Pracodawcy RP i in.), lipiec 2025 —
pracodawcydlazdrowia.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stnowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-RPP-UD-207_FINAL.pdf

J. Materiały prasowe i wywiady

J.1. Wywiad Chmielowca, Menedżer Zdrowia / Termedia, 21.01.2025 J.2. Tweet Szuster-Ciesielskiej, X status 1983941226547065300 z 30.10.2025 J.3. Stanowisko ALIVIA, alivia.org.pl, 10.03.2025 J.4. Rzeczpospolita 01.11.2025 — wyrok WSA V SA/Wa 2854/23 J.5. Konfederacja.pl 8.12.2025 — wygrana SN lekarza opiekującego się pacjentami onkologicznymi w klinice integracyjnej J.6. Bogdan Rymanowski X status 1998041662841405626 (7.12.2025) J.7. Karina Bosak X (8.12.2025) — relacja z postanowienia SN J.8. Gazetą Lekarska, kwiecień 2026 — instytucja publicznego ostrzeżenia RPP

VI. SYSTEM ODSYŁACZY MIĘDZY DOKUMENTAMI

Każdy dokument pakietu, gdy odnosi się do innego, używa formatu:

- **[Sekcja v3.0, §N]** — do paragrafu Sekcji Konstytucyjnej v3.0 (np. „[Sekcja v3.0, §3]” = argument o prawie do obrony)
- **[Memorandum 2.0, A.N]** — do zarzutu głównego Memorandum (np. „[Memorandum 2.0, A.5]” = brak luki + paradoksy farmaceutyczne)
- **[Memorandum 2.0, B.N]** — do zarzutu pomocniczego (np. „[Memorandum 2.0, B.6]” = Oviedo, Jehovah’s Witnesses)
- **[Memorandum 2.0, C.N]** — do rekomendacji (np. „[Memorandum 2.0, C.9]” = vacatio legis 6 mc)
- **[Załącznik 1 v1.10, Część B, §N]** — równoważne odsyłaniu do Sekcji v3.0
- **[Dokument A v3.9, §6.6.5]** — do paragrafu Dokumentu A
- **[Bibliografia, A.14]** — do pozycji w niniejszej bibliografii (np. K 47/14)

W stopce każdego dokumentu pakietu (do wdrożenia w finalnej dystrybucji): *Pakiet obywatelski UD207 v1.10 — [nazwa dokumentu] / Koordynacja: zespół obywatelski, pacjentmaprawo@proton.me / Mapa pakietu: MEMO_DECYZYJNE v3.11.*

VII. STATUS BIEŻĄCY I DECYZJE OPERACYJNE

Stan końcowy (16.05.2026, noc)

— Pakiet zintegrowany merytorycznie. Sekcja v3.0 + Załącznik 1 v1.10 + Memorandum 2.0 są spójne. — Wszystkie dokumenty operacyjne (Apel, Brief, Memo Ekonomiczne, Petycja, List Otwarty) zaktualizowane o ustalenia . — Krytyczne korekty wprowadzone: art. 64a

struktura, tabela art. 58 ust. o zawodach lekarza, błąd Iscador-WSA 2854/23 usunięty, paradoks salinomycyny dopisany.

Otwarte decyzje koordynatora

1. **Wysłać Magdzie** zestaw dokumentów (Komentarz + Analiza z poprawkami + Odpowiedz_Iscador_Salinomycyna + Analiza v2.0 DO_AKCEPTACJI).
2. **Strategia integracji** — wybór modelu z Architektura_Integracji_Pakietu_UD207.docx (rekomendowany: Model 3 — Dwa równoległe deliverables). Wymaga decyzji o statusie Magdy.
3. **Dystrybucja pakietu** — Apel aktywować dopiero po Sejmie/Senacie; pozostałe dokumenty można dystrybuować natychmiast.
4. **Lobbing parlamentarny** — Komisja Zdrowia Sejmu (Arłukowicz + 36 członków): wysłać List Przewodni + Memorandum 2.0 + Petycję.

Następne kroki techniczne

5. Wdrożenie spójnych nagłówków i stopek (formuła w sekcji VI powyżej) — w finalnej rundzie redakcyjnej.
 6. Test krzyżowy odsyłaczy: każdy odsyłacz [Sekcja v3.0, \$N] prowadzi do faktycznego paragrafu — do wykonania przy konsolidacji.
-

VIII. ZAŁĄCZNIK — POPRZEDNIA WERSJA (v3.10)

MEMO_DECYZYJNE_v3.10_aktualizacja_pakietu.docx (15.05.2026) zachowane jako referencja historyczna. Niniejszy dokument v3.11 zastępuje go w pełni i rozszerza o:

— mapę 22 deliverables (wcześniej 16); — glosariusz pojęć; — skonsolidowaną bibliografię w 10 grupach A–J; — system odsyłaczy między dokumentami; — hierarchię dokumentów